

好的，我把“【必填】/【强烈建议】”标注全部删除，保持你们原来**三列（字段 | 填写说明 | 示例）**的单表格式（表1+表2已合并，表3已删除）。

疾病知识图谱（疾病节点模板 | 一病一行）

字段（中文）	填写说明	示例
疾病ID	与基础层疾病主数据关联的唯一键（不在此重复编码/同义名/分类）	DIS_DVT
疾病标准名（可选）	基础层可直接取名则可不填；内容填写更直观时保留	深静脉血栓形成
疾病定义与边界	1-2句：这是什么病；与最相近疾病边界是什么	静脉内血栓形成致回流受阻；不等同表浅静脉炎
典型表现模式	条目化：最常见的症状组合、部位特征、时间特征	单侧下肢肿胀；疼痛/紧绷；近期风险因素
非典型与易漏点	条目化：不典型但仍可能；提示不要因缺失就否定	早期体征不明显；可无明显疼痛
关键支持证据条目ID列表	引用证据条目库中最能支持本病的条目（分号分隔）	E_单侧肿胀；E_久坐久卧；E_疼痛紧绷
关键反对证据条目ID列表	引用明显不支持本病、会推动后移的条目	E_双侧对称性水肿；E_明确红热痛
必须补齐的关键信息条目ID列表	若缺失就无法确认/排除本病的关键信息（缺口清单）	E_起病速度；E_近期手术卧床；E_是否气促胸痛
易混疾病ID列表	最容易混淆、需要重点鉴别的疾病（分号分隔）	DIS_蜂窝织炎；DIS_淋巴水肿；DIS_静脉曲张
关键鉴别点	条目化：用“维度：谁更支持谁”写清（不写问法）	皮肤红热痛：蜂窝织炎更支持；超声血栓：本病更支持
输出依据口径	统一输出时证据条目数量与组织方式（简短）	输出列3-6条关键依据
下一步建议（结构化写法）	固定写法：追问要点；建议检查；处置建议；升级就医条件	追问：血栓风险；检查：下肢静脉超声；升级：胸痛气促立即就医
验证判定标准（成立/排除阈值）	用规则/条目口径写清“满足什么算成立/基本排除”；必须包含“适用前提/阴性限制”	JD_DVT_成立_超声阳性；JD_DVT_排除_满足前提下阴性
结果回填规则	验证结果如何回填并改变层级/排序（置顶/后移/移出/转向子组）	FB_DVT_超声阳性置顶；FB_DVT_阴性后移并转向替代组
升级触发条件（疾病级红旗）	命中即中断常规推理→安全兜底/升级	ESC_DVT_胸痛或明显气促；ESC_DVT_晕厥/咯血
来源条目ID（可选）	只填内部来源条目ID（不写书目）	REF_DVT_001
推理子组归属	该病主要归入哪个“线索簇/推进组”（用于挂接主诉Step3）	SG_血栓风险线索组
分流路径中的位置	标注默认分层/阶段（如Tier2必须优先除外）	Tier2 / must-not-miss
验证计划	优先验证路径（追问/检查的组合路径ID列表）	VP_DVT_超声优先；VP_DVT_高危先兜底
检查价值评估	必要/可选/低价值 + 适用前提一句话	必要：下肢静脉超声（Tier2触发）
回退条件	被反驳后退到哪里/转向哪个子组（规则ID）	RB_DVT_超声阴性→转向SG_感染炎症组
证据链构建规则	输出解释时证据如何选取与排序（模板/规则ID）	EXP_CHAIN_支持Top3+反对Top1
推理路径说明	一句话说明“为何走到这”或引用模板ID	EXP_PATH_单侧+高危→优先除外血栓